

ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO CONTROL DE ESFÍNTER

I. Antecedentes personales:

Nombre : Trinidad Bravo Peña
Rut : 26.688.524-5
Fecha de nacimiento/ edad : 4 de febrero, 2019 / 7 años, 4 meses.
Programa : PAT
Profesionales : T.O. Javiera Carvajal Herrán
Fecha : Junio, 2026
Diagnóstico : **Trastorno del Espectro Autista**

II. Control de esfínter:

El control de esfínter es un proceso de aprendizaje y maduración mediante el cual los niños logran reconocer las señales de su cuerpo y utilizar el baño de manera autónoma para satisfacer sus necesidades fisiológicas.

Actualmente, Trinidad presenta control vesical adquirido, logrando utilizar el baño de forma independiente para orinar. Sin embargo, presenta dificultades en el control intestinal, ya que, a pesar de reconocer la necesidad de defecar y acceder voluntariamente al baño, no logra realizar la deposición en el inodoro.

Según refiere la familia, Trinidad se sienta en el baño, permanece algunos minutos y posteriormente se pone de pie para evacuar en su ropa. Lo anterior permite observar que existe conciencia de la necesidad fisiológica, tolerancia al espacio del baño y comprensión de la rutina, encontrándose la dificultad específicamente en la realización de la deposición en el inodoro.

Es importante considerar que este tipo de situaciones puede estar asociado a factores posturales, sensoriales, emocionales o hábitos previamente instaurados, por lo que requiere un abordaje gradual y respetuoso.

III. Objetivos de Intervención

- Favorecer la realización de deposiciones en el baño.
- Promover experiencias positivas asociadas al uso del inodoro.
- Favorecer la seguridad y confianza durante la evacuación.
- Potenciar la independencia en las rutinas de higiene posteriores.
- Mantener una adecuada participación en las actividades de la vida diaria relacionadas con el baño.

IV. Estrategias de Abordaje

- Mantener horarios regulares para acudir al baño, especialmente después de las comidas.
- Favorecer una postura adecuada mediante apoyo para los pies, permitiendo mayor estabilidad corporal.
- Permitir que Trinidad se incline levemente hacia adelante al estar sentada, favoreciendo una posición fisiológica para la evacuación.
- Utilizar elementos que aumenten la sensación de seguridad, tales como reductor de WC, cojín o apoyos visuales.
- Favorecer actividades de relajación previas, como respiraciones profundas, soplar burbujas o juegos de sopro.
- Observar si existen molestias asociadas al baño (ruidos, olores, temperatura, profundidad del inodoro u otros factores sensoriales).
- Evitar castigos, presiones o insistencias constantes relacionadas con la deposición.
- Reforzar positivamente la participación en la rutina de baño más que el resultado obtenido.
- Favorecer la participación activa en la higiene posterior y cambio de ropa cuando sea necesario.

Estrategias Sensoriales para Trabajar en Casa

1. Compresiones profundas

Realizar antes de los horarios habituales de deposición.

- ❖ Presiones suaves y firmes en hombros, brazos, manos, piernas y pies.
- ❖ Duración: 3 a 5 minutos.
- ❖ Favorece la regulación corporal y disminuye tensión.

2. Masaje abdominal

Realizar diariamente.

- ❖ Movimientos circulares suaves siguiendo el sentido de las agujas del reloj.
- ❖ Puede acompañarse con crema o aceite.
- ❖ Favorece la conciencia corporal y el tránsito intestinal.

3. Actividades de carga pesada (Trabajo propioceptivo)

Realizar 15 a 20 minutos antes de intentar ir al baño.

Ejemplos:

- ❖ Empujar una caja con juguetes.
- ❖ Transportar bolsas livianas.
- ❖ Tirar de una cuerda.

- ❖ Arrastrar almohadas o mantas.
- ❖ Llevar ropa al lavadero.

Estas actividades ayudan a organizar el sistema nervioso y aumentar la percepción corporal.

4. Saltos y movimientos vestibulares

Si Trinidad los disfruta:

- ❖ Saltar en cama elástica.
- ❖ Saltar sobre cojines.
- ❖ Circuitos motores simples.
- ❖ Carrera de obstáculos.

Posteriormente realizar un momento de calma y luego acudir al baño.

5. Juegos de soplo

Favorecen la relajación del abdomen y suelo pélvico.

- ❖ Soplar burbujas.
- ❖ Soplar velas.
- ❖ Soplar pelotas de algodón.
- ❖ Inflar globos.
- ❖ Molinillos de viento.

Realizar sentada antes de ingresar al baño.

6. Posición fisiológica para evacuar

Al sentarse:

- ❖ Pies completamente apoyados.
- ❖ Rodillas más altas que las caderas.
- ❖ Tronco levemente inclinado hacia adelante.
- ❖ Brazos apoyados en las piernas.

7. Caja de regulación para el baño

Tener disponible:

- ❖ Pelota antiestrés.
- ❖ Libro pequeño.
- ❖ Tarjetas visuales.
- ❖ Juguete manipulativo.
- ❖ Temporizador visual.

El objetivo es disminuir ansiedad y favorecer permanencia.

8. Dieta sensorial diaria

Seguir dieta sensorial enviada anteriormente:

- ❖ Columpio.

- ❖ Tregar.
- ❖ Juegos de fuerza.
- ❖ Gatear por túneles.
- ❖ Rodar sobre colchonetas.
- ❖ Abrazos profundos si los disfruta o uso de manta de peso.

V. Rol de la Familia

La familia ha demostrado un adecuado compromiso con el proceso, implementando diversas estrategias para favorecer la adquisición de este hábito. Considerando que Trinidad reconoce la necesidad de evacuar y accede al baño de manera voluntaria, se recomienda continuar acompañando el proceso desde una mirada respetuosa y libre de presión.

De este modo, se sugiere:

- Mantener una rutina estable y predecible respecto al uso del baño.
- Evitar que el control intestinal se transforme en un tema central de conversación durante el día.
- No realizar preguntas reiteradas respecto a si tiene ganas de defecar.
- Mantener una actitud neutral frente a los accidentes, evitando manifestar frustración o desagrado.
- Favorecer la independencia en el cambio de ropa y rutinas de higiene posteriores.
- Observar si existen patrones específicos relacionados con horarios, lugares o posturas utilizadas al momento de evacuar.
- Favorecer una adecuada hidratación y alimentación equilibrada.
- Consultar con profesionales de salud en caso de sospecha de estreñimiento, dolor o molestias asociadas a la evacuación.

VI. Pronóstico

Trinidad presenta habilidades precursoras importantes para la adquisición de este hábito, tales como reconocimiento de la necesidad fisiológica, acceso voluntario al baño, tolerancia al espacio y control vesical independiente.

No obstante, la dificultad para realizar deposiciones en el inodoro se ha mantenido pese a las estrategias implementadas, por lo que el avance dependerá principalmente del respeto por sus tiempos individuales, la continuidad de los apoyos y la disminución de situaciones de presión asociadas al proceso.

Actualmente, el objetivo principal es favorecer una participación positiva y segura en la rutina de baño, promoviendo progresivamente la adquisición de esta habilidad.